Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Клиническая картина 4

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Фарингоскопия и общий осмотр 4

3.3 Экспресс-тест на БГСА 5

3.4 Бактериологическое исследование мазка из зева 5

3.5 Дифференциальная диагностика стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита 5

3.6 Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями 6

3.7 Исследования, не показанные рутинно 7

4. Лечение 7

4.1 Вирусный тонзиллофарингит 7

4.2 Стрептококковый тонзиллофарингит 7

4.3 Дозы для приёма внутрь 8

4.4 Парентеральная терапия 9
4.5 Симптоматическая терапия 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения **10**
6. Источник и актуальность **11**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Возбудителями тонзиллофарингита в большинстве случаев являются вирусы, и антибактериальная терапия при этом не показана. Из бактериальных возбудителей лечения требует только бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА); выделение из зева стафилококка, пневмококка и других микроорганизмов расценивается как колонизация.
- По клинической картине отличить вирусный тонзиллофарингит от бактериального невозможно. Пациентам **старше 3 лет** выполняют экспресс-тест на БГСА; при отрицательном результате у ребёнка его подтверждают бактериологическим исследованием (посевом).
- Антибактериальная терапия назначается только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии. При вирусной инфекции антибиотики неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
- Препаратом выбора является амоксициллин, курс лечения составляет **10 дней**.
- При отсутствии улучшения **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии следует пересмотреть диагноз: заболевание может быть обусловлено острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или инфекционным мононуклеозом.
- Показания к госпитализации:

  Госпитализация в инфекционное отделение

  1. тяжёлое состояние;
  2. отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии.

  Консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение

  1. подозрение на гнойное осложнение;
  2. атипичная клиническая картина;
  3. необходимость хирургического вмешательства.
- Рутинно не показаны:
  1. определение С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина;
  2. общий анализ крови в амбулаторных условиях;
  3. исследование антистрептолизина О (АСЛ-О);
  4. контрольный мазок после лечения.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит является острым инфекционным воспалением слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки (нёбных миндалин и лимфоидных фолликулов задней стенки глотки). Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, поскольку чаще в воспалительный процесс вовлекаются оба отдела.

По локализации (преимущественно поражённый отдел ротоглотки)

1. тонзиллит;
2. фарингит;
3. тонзиллофарингит.

По этиологии

1. стрептококковый;
2. нестрептококковый (вирусный).

Тактика лечения определяется этиологией.

2.2 Клиническая картина

Заболевание начинается остро.

1. повышение температуры тела **выше 38 °C**, реже температура нормальная или субфебрильная;
2. боль в горле, усиливающаяся при глотании, возможна иррадиация в ухо;
3. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
4. у детей младшего возраста отказ от еды.

Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

2.3 Чувствительность возбудителя и колонизация

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. Устойчивость к макролидам выявляется примерно у каждого пятого штамма, к клиндамицину у 3–4%.

Выделение из зева *S. aureus*, *S. pneumoniae* или других бактерий при клинической картине тонзиллофарингита расценивается как колонизация и не требует назначения антибиотиков.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

3.1 Критерии диагноза

1. жалобы на выраженную боль в горле при глотании;
2. данные осмотра: гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличение регионарных лимфатических узлов;
3. результаты экспресс-теста на БГСА или бактериологического исследования.

3.2 Фарингоскопия и общий осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога, педиатра, врача общей практики или терапевта.

Признаки стрептококковой этиологии

1. увеличение подчелюстных или переднешейных лимфатических узлов;
2. высокая температура тела;
3. выраженная боль в горле;
4. «пылающий зев»;
5. налёт на миндалинах;
6. отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

Признаки вирусной этиологии

1. насморк;
2. конъюнктивит;
3. кашель;
4. при инфекции вирусом Эпштейна — Барр генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки.

Петехии на мягком нёбе встречаются как при стрептококковой инфекции, так и при инфекции вирусом Эпштейна — Барр.

Также следует учитывать

1. У детей старше 3 лет насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит при стрептококковой инфекции встречаются **не более чем у 10%** пациентов и только при сопутствующей вирусной инфекции.
2. Симметричное увеличение миндалин отличает тонзиллофарингит от паратонзиллярного абсцесса.

3.3 Экспресс-тест на БГСА

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**.

Оценка результата

1. положительный результат: посев не требуется;
2. отрицательный результат у взрослых: посев не требуется;
3. отрицательный результат у детей и подростков: результат подтверждают бактериологическим исследованием.

Детям до 3 лет экспресс-тест рутинно не проводится; исключением является стрептококковый тонзиллит у кого-либо из окружения ребёнка, например у старшего брата или сестры.

3.4 Бактериологическое исследование мазка из зева

Показания

1. пациенты **старше 3 лет**, если экспресс-тест не проводился или его результат отрицательный.

Результат готов **в течение 72 часов**.

Забор материала

1. до начала антибактериальной терапии;
2. до утренней гигиены полости рта, натощак или через 2 часа после еды;
3. под контролем орофарингоскопии, без касания зубов и языка;
4. из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.5 Дифференциальная диагностика стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита

Дифференциальную диагностику стрептококкового и вирусного тонзиллофарингита проводят у каждого пациента. Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции.

Шкала Центора в модификации МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1

Признак	Баллы
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Отсутствие катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Лечебная тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Посев и/или антибактериальная терапия не показаны
2–3	21–38% / 23–37%	Антибактериальная терапия по результатам экспресс-теста и/или посева
4 и более	57% / 55%	Антибактериальная терапия на основании клинической картины

Шкала FeverPAIN

По одному баллу начисляется за каждый признак: повышение температуры тела за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня в связи с выраженными симптомами, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

Вероятность стрептококковой инфекции групп A, C или G составляет 16% при 0–2 баллах, 43% при 3 баллах, 63% при 4–5 баллах.

Шкалы позволяют выявить пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, однако не дают возможности установить диагноз с абсолютной точностью.

3.6 Дифференциальная диагностика с другими заболеваниями

1. Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и лица молодого возраста до 30 лет. Характерны слабость, лимфаденопатия, увеличение печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в периферической крови. Диагноз подтверждается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ДНК вируса Эпштейна — Барр и выявлением IgM к капсидному антигену.
2. Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, как правило в летний период: на слизистой оболочке полости рта появляются везикулы без налётов на миндалинах, на кистях и стопах отмечается сыпь.
3. При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине формируется некротическая язва, отмечается гнилостный запах.
4. При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом, после снятия остаётся кровоточащая поверхность.
5. Синдром Маршалла (PFAPA) характеризуется периодической лихорадкой до 39–40 °C в сочетании с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей составляет 5 лет; приступ быстро купируется системными кортикостероидами.

3.7 Исследования, не показанные рутинно

В амбулаторных условиях определение СРБ и прокальцитонина не позволяет отличить вирусное воспаление от бактериального.

Показания

1. СРБ: госпитализация;
2. прокальцитонин: тяжёлое состояние пациента в стационаре.

Общий анализ крови в амбулаторных условиях рутинно не выполняют.

Показания

1. исключение инфекционного мононуклеоза и другие показания.

АСЛ-О применимо только для ретроспективной диагностики: его уровень повышается лишь **на 7–9-й день**.

Показания

1. подозрение на ревматическую лихорадку;
2. подозрение на гломерулонефрит;
3. подозрение на детские аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).

Контрольный мазок на БГСА после лечения не показан.

Исключения

1. высокий риск ревматической лихорадки;
2. рецидив симптомов.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Вирусный тонзиллофарингит

1. Системные антибактериальные препараты не применяют: они неэффективны и не предотвращают присоединения бактериальной инфекции.
2. Профилактическое назначение антибиотиков не рекомендуется.
3. Симптоматическая терапия (ниже).

4.2 Стрептококковый тонзиллофарингит

1. Антибактериальную терапию назначают только при доказанной или высоковероятной стрептококковой этиологии.
2. Препарат выбора: амоксициллин.
   При инфекционном мононуклеозе на фоне приёма амоксициллина возможно появление сыпи, однако она возникает и при приёме других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе следует избегать назначения любых системных антибактериальных препаратов.
3. Курс пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов и макролидов, кроме азитромицина, составляет **10 дней**.
4. Если **через 48–72 часа** от начала антибактериальной терапии температура тела и боль в горле не уменьшились, следует пересмотреть диагноз: наиболее вероятны ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
5. При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите препараты выбора: амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) курсом **10 дней**. Необходима

консультация оториноларинголога для исключения хронического тонзиллита, у детей также синдрома PFAPA.

6. При нетяжёлой аллергии на пенициллины: цефалоспорины II–III поколения (цефуроксим, цефиксим, цефдиторен, цефподоксим). Перекрёстная аллергия с пенициллинами встречается менее чем в 2% случаев для цефалоспоринов II поколения и менее чем в 1% для III поколения.
   Уровни доказательности для этих препаратов в рекомендации различаются: для цефуроксима УУР С, УДД 5; для цефиксима С и 5 у детей, В и 1 у взрослых; для цефдиторена С и 2; для цефподоксима В и 2. Курс лечения составляет 10 дней.
7. При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница): макролиды или линкозамиды с учётом возможной устойчивости стрептококка к макролидам.
8. Бензатина бензилпенициллин однократно внутримышечно вместо курса приёма внутрь только при сомнениях в том, что пациент будет принимать препарат. Доза для детей с массой тела до 27 кг составляет 600 тысяч ЕД, более 27 кг 1,2 миллиона ЕД.

4.3 Дозы для приёма внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия, 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня

Препарат	Взрослые	Дети
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] При сомнениях в соблюдении пациентом назначений, ревматической лихорадке у пациента или его родственников, неблагоприятных бытовых условиях и вспышках инфекции в коллективе. [3] Доза клавулановой кислоты не должна превышать 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте 250 мг 2 раза в сутки, в таблице 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 40 мг/кг в сутки, в таблице 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки, в таблице в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор дозы остаётся за врачом; дозы следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

4.4 Парентеральная терапия

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, антибиотик вводится парентерально до стабилизации состояния с последующим переходом на пероральный приём.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (при тяжёлом течении — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.5 Симптоматическая терапия

При лихорадке и болевом синдроме применяют ибупрофен, парацетамол или, у пациентов старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям применяют только парацетамол и ибупрофен.

Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающие назначают при температуре

1. **выше 39,0 °C** при измерении в прямой кишке;
2. **выше 38,5 °C** в подмышечной впадине.

Ибупрофен: взрослым 200–400 мг, детям 7,5 мг/кг, не более 30 мг/кг в сутки. Парацетамол: взрослым 500–1000 мг, детям 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначаются.

Исключением являются выраженный дискомфорт и угроза асфиксии, например при инфекционном мононуклеозе. В этом случае однократно внутрь назначается #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При выраженном болевом синдроме используют местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде спреев, растворов и таблеток для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение не заменяет системную антибактериальную терапию.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином у детей старше 4 лет, флурбипрофен старше 12 лет, кетопрофен с 12 лет. Препараты для лечения заболеваний горла в целом применяются с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. «Смазывание» миндалин и механическое удаление налётов не рекомендуются.

Дополнительно, в том числе курсами в межрецидивный период, возможно применение растительных препаратов: корня алтея, ромашки, тысячелистника, коры дуба, хвоща, листьев грецкого ореха, одуванчика.

Рекомендуется ограничение раздражающей пищи (острой, кислой, солёной, горячей и холодной); пища должна иметь мягкую консистенцию.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта с больным стрептококковой инфекцией антибиотикопрофилактика показана:

1. беременным со сроком гестации **37 недель и более**;
2. новорождённым и родильницам **в первые 28 дней**;
3. лицам в возрасте **75 лет и старше**.

Больные стрептококковым тонзиллофарингитом подлежат изоляции от организованных коллективов, их контакты ограничиваются.

Для профилактики рецидивов тонзиллофарингита применяют лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациент находится под наблюдением **в течение месяца**:

1. общий анализ крови и мочи **через 7–10 дней** и **через 3 недели**;
2. электрокардиография (ЭКГ) при жалобах со стороны сердца.

Лечение, как правило, амбулаторное. На фоне антибактериальной терапии улучшение наступает через 12–24 часа. Ребёнок допускается в детский коллектив после полного выздоровления.

Госпитализация в инфекционное отделение

1. тяжёлое состояние;
2. отказ от еды и питья, требующий инфузионной терапии.

Консультация оториноларинголога и госпитализация в хирургическое отделение

1. подозрение на гнойное осложнение;
2. атипичная клиническая картина;
3. необходимость хирургического вмешательства.

Гнойные осложнения стрептококковой инфекции

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингеальный абсцесс;
3. ретрофарингеальный абсцесс;
4. гнойный лимфаденит.

Негнойные осложнения

1. острая ревматическая лихорадка;
2. ревматическая болезнь сердца;
3. постстрептококковый гломерулонефрит;
4. стрептококковый токсический шок;
5. PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина с клавулановой кислотой и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются; расхождения приведены в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» указано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед»; по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются с нарушением порядка строк, поэтому все строки сверены по изображениям страниц 19–21.